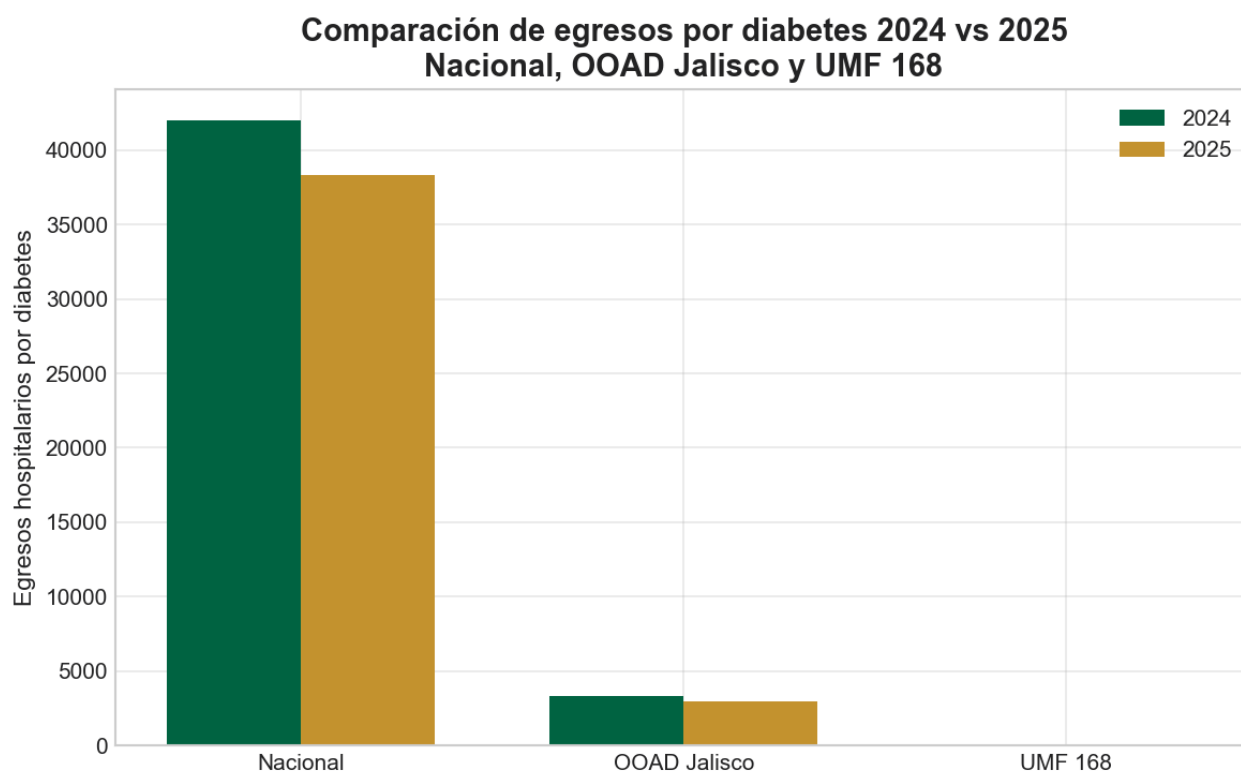


Egresos hospitalarios por diabetes 2024-2025: Nacional, OOAD Jalisco y UMF 168

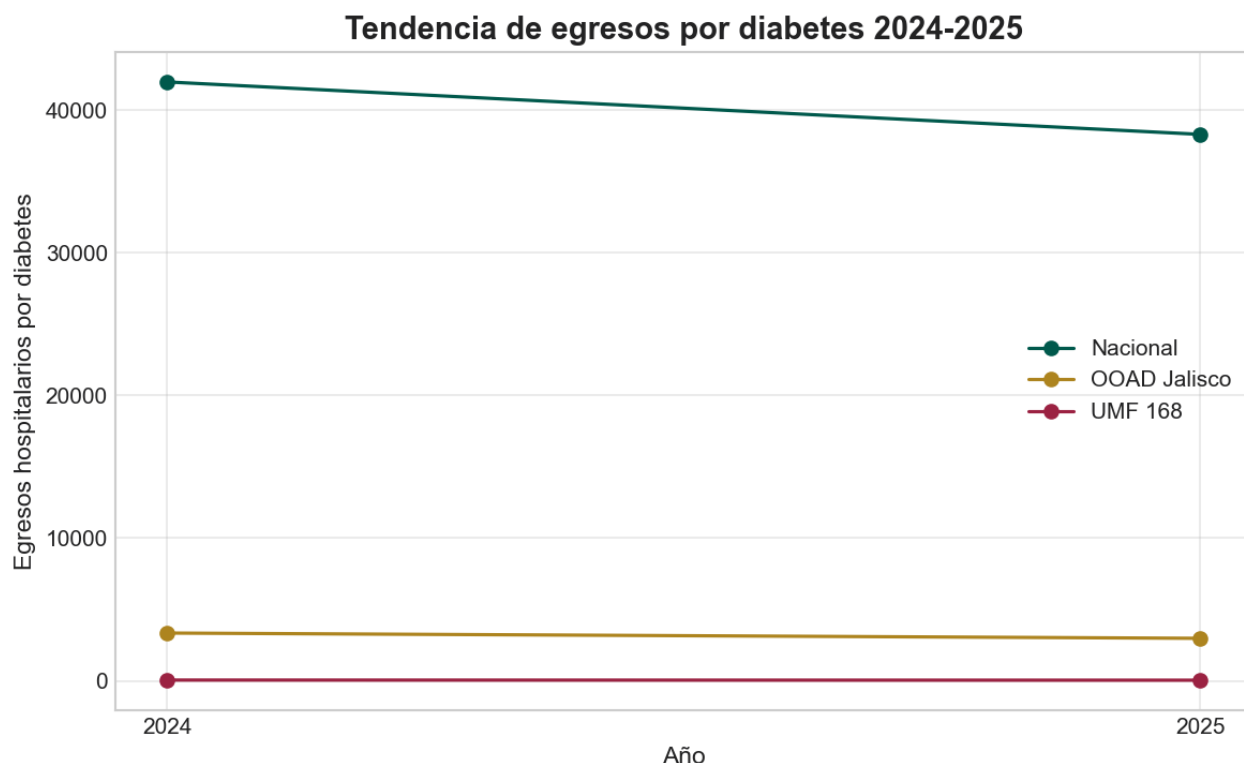
1. Introducción

Este reporte presenta el comportamiento de los egresos hospitalarios por diabetes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los años 2024 y 2025, con énfasis en tres niveles de análisis: ámbito nacional, la Oficina de Representación Jalisco (OOAD Jalisco) y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 168 Tepatitlán. El objetivo es proporcionar a los tomadores de decisión una visión comparativa de la carga de hospitalización por diabetes y su variación interanual, identificando posibles áreas de mejora en la atención y en las estrategias de prevención y control de la enfermedad.

3. Evidencia Gráfica



Egresos hospitalarios por diabetes 2024-2025: Nacional, OOAD Jalisco y UMF 168



4. Análisis e Interpretación

1. Resultados globales de egresos por diabetes

En el ámbito nacional, los egresos hospitalarios por diabetes pasaron de 41,969 en 2024 a 38,295 en 2025, lo que representa una disminución absoluta de 3,674 egresos y una reducción relativa aproximada de 8.75%. Esta tendencia sugiere una posible contención de la carga hospitalaria por diabetes, aunque es necesario interpretar estos datos en conjunto con indicadores de calidad de la atención y mortalidad.

Para la OOAD Jalisco, los egresos disminuyeron de 3,346 en 2024 a 2,976 en 2025, con una reducción absoluta de 370 egresos y una variación relativa de -11.06%. La reducción es mayor que la observada a nivel nacional, lo que podría estar asociado a mejoras en el manejo ambulatorio, fortalecimiento de programas de control metabólico o cambios en los criterios de referencia y hospitalización.

En la UMF 168 Tepatitlán, los egresos hospitalarios por diabetes pasaron de 51 en 2024 a 42 en 2025, con una disminución de 9 egresos y una variación relativa de -17.65%. Aunque el volumen absoluto es bajo, la reducción proporcional es la más marcada de los tres niveles analizados, lo que puede indicar un mejor control de los pacientes adscritos o cambios en los patrones de referencia hacia otros niveles de atención.

2. Comparación interanual y gradiente entre niveles

Egresos hospitalarios por diabetes 2024-2025: Nacional, OOAD Jalisco y UMF 168

El análisis comparativo muestra un gradiente consistente de reducción de egresos entre 2024 y 2025 en los tres niveles (nacional, estatal y unidad médica). La mayor reducción relativa se observa en la UMF 168, seguida de la OOAD Jalisco y finalmente el ámbito nacional. Este patrón sugiere que las intervenciones locales y regionales pueden estar teniendo un impacto relevante en la disminución de la necesidad de hospitalización por diabetes.

La gráfica de barras comparativas ilustra claramente la diferencia de magnitud entre los niveles: el ámbito nacional concentra la mayor carga absoluta de egresos, seguido por la OOAD Jalisco y, en menor medida, la UMF 168. Sin embargo, al analizar las variaciones porcentuales, se observa que los cambios relativos son más pronunciados en los niveles subnacionales.

La gráfica de tendencia por año refuerza la observación de una disminución sostenida entre 2024 y 2025 en los tres ámbitos. Aunque solo se cuentan con dos puntos temporales, la dirección del cambio es consistente y apunta hacia una reducción de la carga hospitalaria por diabetes.

3. Consideraciones epidemiológicas y operativas

Es importante interpretar la disminución de egresos con cautela. Una reducción en hospitalizaciones por diabetes puede ser positiva si está asociada a un mejor control glucémico, detección oportuna de complicaciones y fortalecimiento del primer nivel de atención. Sin embargo, también podría reflejar barreras de acceso, cambios en la capacidad hospitalaria o en los criterios de admisión.

Para una interpretación integral, se recomienda complementar este análisis con:

- Tasas de hospitalización por 100,000 derechohabientes, utilizando la población adscrita como denominador.
- Indicadores de calidad de la atención (reingresos, mortalidad intrahospitalaria, días promedio de estancia).
- Información sobre la implementación de programas de prevención y control de diabetes en las unidades analizadas.

4. Síntesis numérica de la variación 2024-2025

La tabla de resumen incluida en este reporte presenta, para cada ámbito (Nacional, OOAD Jalisco y UMF 168 Tepatitlán), los egresos totales en 2024 y 2025, así como el cambio absoluto y el porcentaje de variación. En términos generales:

- Nacional: -3,674 egresos (-8.75%).
- OOAD Jalisco: -370 egresos (-11.06%).
- UMF 168 Tepatitlán: -9 egresos (-17.65%).

Estos resultados permiten priorizar el seguimiento en aquellos ámbitos donde la reducción es más marcada, para identificar buenas prácticas que puedan ser replicadas, así como descartar que la disminución se deba a problemas de acceso o subregistro.

Egresos hospitalarios por diabetes 2024-2025: Nacional, OOAD Jalisco y UMF 168

5. Conclusiones y Recomendaciones

1. Entre 2024 y 2025 se observa una disminución consistente de los egresos hospitalarios por diabetes en los tres niveles analizados (nacional, OOAD Jalisco y UMF 168 Tepatitlán), con reducciones relativas que oscilan entre -8.75% y -17.65%.
2. La OOAD Jalisco presenta una reducción de egresos mayor que la media nacional, lo que sugiere un posible impacto positivo de las estrategias regionales de prevención y control de la diabetes, que amerita ser documentado y, en su caso, replicado en otras OOAD.
3. La UMF 168 Tepatitlán, aunque con un volumen absoluto bajo, muestra la mayor reducción porcentual de egresos, lo que indica una oportunidad para analizar en detalle sus prácticas de manejo ambulatorio, seguimiento de pacientes crónicos y coordinación con el segundo nivel.
4. La sola disminución de egresos no es suficiente para concluir una mejora en la situación de salud; es indispensable complementar este análisis con tasas ajustadas por población, indicadores de calidad de la atención y resultados en salud (mortalidad, complicaciones, reingresos).
5. Se recomienda establecer un monitoreo trimestral de los egresos por diabetes, incorporando tasas por 100,000 derechohabientes y desagregación por sexo y grupo de edad, a fin de detectar oportunamente cambios en la demanda de hospitalización y orientar la planeación de recursos y acciones preventivas.